



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : شيرين رضا عويس ابراهيم
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : الصف
رقم البطاقة : 28205012102328 رقم التليفون : 01157178770
العنوان : ممممممممممممممم
العمر (تاريخ الميلاد) : 01-05-1982 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 26-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي زولاديكس تحت الجلد لمدة 6 شهور
قسم العلاج :
الاورام

[14163]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: شيرين رضا عويس ابراهيم National ID: 28205012102328	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Goserelin (Zoladex) subcutaneous

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

شبرين
رضا عويس ابراهيم
قرية نجوع العرب
مركز الصنف - النجيزة



٢٨٢٠٥٠١٢١٠٢٣٢٨

987

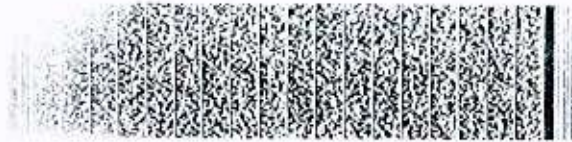
٢٠١٥/٠٢ ٢٨٢٠٥٠١٢١٠٢٣٢٨

حاصلة على دبلوم صنایع



أنثى مسلمة مقروجة
سعيد عبدالعظيم حسين سليمان

البطاقة سرية حتى ٢٠٣٢/٠٢/٢١





Pathology Report

Name: شرين رضا عويس

Age: 38 years.

Clinical data: Left breast mass, post chemotherapy.

Specimen type: Wide local excision.

Date (Received): 13/6/2021.

Date(reported): 20/6/2021

Lab. Number: 1215 / 21

Hospital Number: نفقة

Gross Examination:

Two specimen were received and submitted as:

- (1) WLE, breast tissue measure 6x4x2 cm, skin ellipse 2x0.9 cm.
Extra margin 7x6x2 cm
- (2) Axillary lymph nodes, 16 nodes up to 1cm in diameter.

- Procedure: WLE
- Localization: left breast
- Tumor extent: (tumor bed site)
 - Number: one
 - Size: 0.4x0.4 cm
 - Skin involvement: No
- Distance from margins:
- Lymph nodes number and size: 16 LNs, 1 cm in diameter.
- Additional pathologic findings:
- Immunohistochemistry technique:

Name: شرين رضا عويس ابراهيم		
MR. : 7468		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient is a 44-year-old premenopausal individual who presented with a left breast mass staged clinically as cT2N1. Pathology demonstrated strong hormone receptor positivity (ER 7/8, PR 8/8) and HER2 3+. Neoadjuvant chemotherapy was administered consisting of AC for four cycles followed by Taxol/herceptin for four cycles. Breast-conserving surgery was performed in June 2021, yielding pathology of pT1N0. Post-operative radiotherapy and adjuvant Kadcyla were given, and hormonal therapy was initiated in August 2021. The most recent breast ultrasound on 28 January 2026 was negative, and abdominal ultrasound was also negative. The patient has been prescribed Arimidex for three months together with Zoladex, and plans are in place for laboratory monitoring after three months of Zometa therapy. The patient has completed 4 cycles of AC and 4 cycles of Taxol/herceptin. At the follow-up visit, the patient received Zometa and laboratory results were within normal limits. Continuation of Zoladex and Arimidex for a three-month course was confirmed, with prescriptions filled on 1 August and 29 August. The current plan is to maintain the endocrine therapy and monitor labs as scheduled.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	التاريخ : 18-09-2026
	هنا أسامه عبد الرحيم عبد البر	
الطبيب المعالج :		
يعتمد ,		

Microscopic examination:

- Histological type: **invasive duct carcinoma**
- **Grade II**
- **Angioinvasion: No**
- **Ductal carcinoma in situ: Yes(5%)**
- **Tumor extent: (tumor bed site)**
 - **Number: One**
 - **Size: 0.4x0.4 cm**
 - **Skin involvement: No**
- **Lymph node involvement: 0/16**
- **Resection Margins: Free**
 - **Free /DCIS/ invasive carcinoma**
- **Additional pathologic findings: N/A**

Diagnosis:

Localization, Procedure: Left breast, Wide Local Excision

- **Invasive duct carcinoma grade II**
- **ypT1 ypN0**

Prof. Dr. Amal Hareedy.

Dr. Mona Mohamed.

PATIENT NAME: SHERIN REDA AWEES IBRAHIM	PATIENT ID #: 2020138236
GENDER: Female	ORDER #: 876833,876834
AGE: 38 y	DATE OF SERVICE: 29-Nov-2020 01:09 PM

Report: - all studies

Multi-slice post contrast CT scan of the chest, abdomen and pelvis revealed:

(I) Chest:

- Left breast heterogenous enhancing lesion measures about 3.3 x 2.3 cm along its maximal axial diameter. Prominent left axillary lymph nodes, reaches 2 x 1.2 cm along its maximal axial diameter.
- Right lower lobe posterior segment pulmonary nodule, measures about 8 mm along its maximal axial diameter, likely of indeterminate/non-specific nature.
- Basal parenchymal atelectatic bands.
- No CT evidence of hilar or mediastinal lymph node enlargement.
- Left aberrant subclavian artery (variant).
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size showing segment VII tiny focus is noted, showing no definite contrast enhancement, likely simple cyst, for follow-up.
- Patent and homogeneously enhancing portal vein.
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys, aorta and IVC.
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.
- Para-umbilical fat containing hernia.
- IUD is seen in-place.
- No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- The examined part of the skeleton showing:
 1. D7 and D8 vertebral lytic lesion with internal striations, likely vertebral

osseous hemangiomas.

2. No destructive osseous lytic lesions.

OPINION:

- *Left Breast lesion with prominent left axillary lymph nodes.*
- *Tiny hepatic hypodense focus, possibly of benign nature (cyst) for follow-up.*
- *No pulmonary or osseous metastatic lesions.*

Reported By,

Dr. Kareem Moussa, MD
Dr. Mahmoud Saleh, MSc

30-Nov-2020 02:39 PM

Ref Name : الأستاذة / شيرين رضا عويس إبراهيم

Ref No. : 28205012102328

Age : 916/24

: Female

: 41 Y

Referring Doc :

Request No. : 13002165

Request Date : 05/03/2024

Verification Date : 18/03/2024

Financial Category : نفقة الدولة - أورام دار السلام

Department : Out Patient

Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

CLINICAL DATA

Left breast swelling

NATURE OF SPECIMEN

Tru cut biopsy, collected 4/3/2024

GROSS PATHOLOGY

Two greyish tissue cores, 2 and 0.8 cm long, totally submitted

HISTOPATHOLOGY

Histopathological examination reveals a biphasic growth made up of proliferating small patent mammary ducts. Some of the ducts are compressed and closed, other are patent. The ducts are lined by inner columnar and outer myoepithelial cells. The stroma in between is formed of loose fibrous connective tissue. There is no evidence of malignancy in sections examined.

DIAGNOSIS

Left breast swelling. Tru cut biopsy:

Myoepithelial lesion

No malignancy

SIGNATURE

Dr.Rana Fathy

Dr.Muhammad Torkey

Verified by :

Dr.Mohamed Torky





ImmunohistoChemistry report

Report Number: m334

Female :	النوع	شيرين رضا عويس	اسم المريض :
القاهرة :	العنوان	38 Y	السن :
17/01/2021 09:27 :	تاريخ استلام العينة		تاريخ اخذ العينة :
23/01/2021 12:45 :	تاريخ التقرير	مركز اورام دار السلام	طالب التحليل :
		مركز اورام دار السلام	خفية :

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

ER & PR & HER2 neu & Ki67 (ER&PR: Harvey scoring system -Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

sample recieved was treated by: - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody.- CONFIRM anti-progesterone receptor(PR) (IE2)Rabbit monoclonal primary antibody.

Sample recieved was treated by: -VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX.

Sample recieved was treated by: - CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbeit monoclonal primary antibody.

Result :

ER: moderate nuclear staining of 80 % of tumour cells

PR: moderate nuclear staining of 80 % of tumour cells

HER2/neu protein over expression : strong continuous membrane staining of > 10 % of tumor cells.

Ki67 :positive nuclear staining of 50-60 % of tumour cells

Referral Lab :

Comment :

Conclusion :

ER: POSITIVE (SCORE 7/8)

PR: POSITIVE (SCORE 7/8)

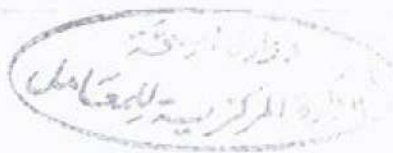
HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : POSITIVE (SCORE 3+)

#Ki67: THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS 50-60 %
(CORE BIOPSY)

Pathologist:

د/ايمن رمزي

Lab Director: د/ تيريزا ماهر





Patient Name: Sherine Reda Owais Ibrahim	Date : 01/02/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 42 Year(s)
Medical ID: 5665/2020	Pat. ID: 26443

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY

Indication:

Patient had left CBS, coming for follow up on left UOQ microcalcifications

Technique

- Bilateral MLO and CC views

Report:

- The breasts are almost entirely fatty (ACR A)
- No right breast suspicious mass lesions, micro calcifications or architectural distortion detected.
- Left breast UOQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness, with UOQ group of pleomorphic microcalcifications measuring 3.7x2 cm seen 10 cm from the nipple.
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.

Opinion:

- Left breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions, with still noted UOQ indeterminate microcalcifications. For stereotactic guided biopsy to confirm the biopsy from the microcalcifications (BIRADS 4a)
- Normal study of the right breast (BIRADS 1)

Yours truly

Signature Dr. Yasmin Nada

01/02/2025 11:19 AM